항암 구역·구토에 올란자핀(olanzapine)을 처방받으셨다면

올란자핀은 정신과에서도 쓰는 약이지만, 항암제 때문에 생기는 구역·구토에 매우 효과적인 약입니다. 처음에는 졸릴 수 있어도 곧 적응하고, 이후 구역·구토가 아주 잘 조절될 것입니다.

올란자핀을 왜 처방받았을까요



신호 경로 여러 곳을 한 알이 함께 막습니다

처방 이유

항암제로 생기는 구역·구토(CINV, 항암제 유발 구역·구토)는 항암 치료를 받는 병원에서 **미리 예방약**을 씁니다. 그래도 구역·구토가 생기면 예방요법에 쓰지 않은 **다른 작용 방식의 약**을 더하는 것이 좋고, 그중 강하게 권하는 약이 올란자핀입니다.

올란자핀은 5-HT_2(세로토닌)·D_2(도파민)·히스타민 등 **여러 곳을 한꺼번에 막는 약**입니다. 병원 예방요법에 온단세트론·팔로노세트론 등이 들어갔다면 올란자핀을 더하는 쪽이 더 유익합니다.

약국에서 "정신과에서 쓰는 약"이라는 말을 들으실 수 있습니다. 정신과에서 쓰는 약이 맞지만 **구역·구토에 매우 효과적**이라 처방한 것입니다.

이렇게 드십니다

1회 용량	복용 기간	고령 환자
5mg	**3일 정도**	**2.5mg**
하루 한 번 드시는 용량으로 권합니다	하루 한 번 × 3일	절반 용량도 효과가 좋습니다

발표 슬라이드에는 **5~10mg, 하루 한 번, 3일**로 적혀 있습니다. 질의응답에서 연자는 "보통 **2.5mg만 해도 효과가 아주 좋다**"고 답했습니다. 실제 용량과 기간은 **처방전대로** 드세요.

졸림 — 처음 드시면 잠이 많이 온다는 분들이 있습니다. 연자는 초반에 졸릴 수 있지만 **곧 적응되어 괜찮아지고** 구역·구토는 아주 잘 조절될 것이라고 설명했습니다.

예방약에도 구토가 생길 때(돌발성) 지키는 3가지

1 다른 작용의 약 추가
예방요법에 쓰지 않은 **다른 기전의 약**을 더합니다. 올란자핀이 여기에 해당합니다.

2 정해진 시간에 규칙적으로
필요할 때만(PRN) 드시기보다 **정해진 시간에 규칙적으로** 드시도록 처방합니다.

3 탈수·전해질 함께 바로잡기
구토로 빠져나간 **수분과 전해질**을 보충하는 치료를 함께 합니다.

약값·보험 — 질의응답에서 연자의 답변

올란자핀 급여 처방이 가능한지 묻는 질문에 연자는 올란자핀이 **인정 비급여 약제**라고 답했습니다. 연자 병원 기준 약가는 **2.5mg 645원 · 5mg 1,106원 · 10mg 1,965원**이라고 했습니다.

내 항암제의 구토 위험도 (예방요법을 쓰지 않았을 때 기준)

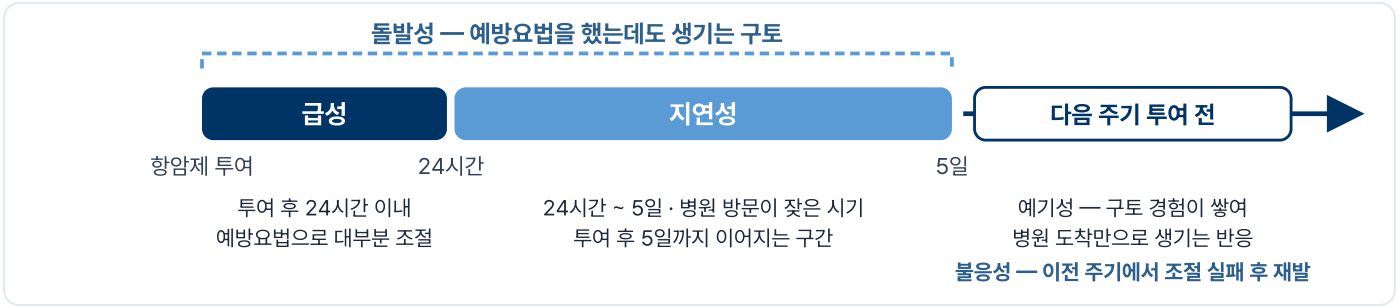
위험도	구토 발생	대표 항암제
고도	**90% 초과**	시스플라틴 · 카보플라틴(AUC≥4) · AC 요법 · 다카바진 등
중등도	**30~90%**	옥살리플라틴 · 이리노테칸 · 독소루비신 · 시클로포스파미드 등
경도	**10~30%**	탁산(파클리탁셀·도세탁셀) · 젬시타빈 등
최소	**10% 미만**	대부분의 단클론항체·면역항암제

여러 항암제를 함께 쓰면 **가장 위험도가 높은 약**을 기준으로 나눕니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

뒷면에 구역·구토의 종류, 다른 약, 큰 병원에 가야 하는 신호가 이어집니다.

구역·구토는 언제, 어떤 모양으로 생길까요



예기성은 이전에 구역·구토를 너무 많이 겪어 흰 가운을 보거나 병원에 도착하자마자 구토하는 **조건화된 반응**입니다. 예방약은 항암제를 투여한 병원에서 이미 쓰기 때문에 의원에서는 주로 지연성·돌발성·예기성 구토를 만나게 됩니다.

구토를 막는 입으로 먹는 약 비교

약	용량·횟수	언제 쓰나	주의
올란자핀 (Olanzapine)	5~10mg, 1일 1회 × 3일 (연자는 5mg 권장)	돌발성 1차 선택	진정·졸림 — 처음에만 심하고 곧 적응
메토클로프라미드 (맥페란)	10mg, 1일 3회	구역·구토가 있을 때 쓰는 구제 약제	오래 쓰면 추체외로 증상(몸이 굳거나 떨리는 움직임 이상) — 보통 **3일, 길어도 5일**
로라제팜 (Lorazepam)	0.5~1mg, 필요할 때	예기성 구토, 불안이 함께 있을 때	예기성 구토에서는 0.5~1mg 처방이 효과적입니다
덱사메타손 (Dexamethasone)	4~8mg, 1일 1~2회	지연성 구토	당뇨·불면 주의. 항암 병원에서 이미 쓰므로 의원에서는 쓸 일이 잘 없습니다

⚠ 이럴 때는 큰 병원(응급실)으로

- 입으로 **수분·약을 계속 못 넘기는** 지속 구토
- 탈수 징후 — **일어설 때 어지러움·소변량 감소**, 혈중 K·Na 이상
- **피가 섞이거나 커피색인 구토**, 심한 복통, 의식 저하
- 24시간 이상 아무것도 못 드시거나, 고령으로 매우 쇠약한 경우
- 구토약을 써도 **24~48시간 조절되지 않을 때**
- 구토와 함께 **아주 심한 두통** — 뇌압이 올라 뇌전이와 관련될 수 있습니다
- 열 38.3°C 이상, 또는 38.0°C 이상이 1시간 넘게 계속될 때

항암제 때문만이 아닐 수도 있습니다

- 변비·장이 막힘 — 배가 부르거나 가스가 나오는지
- 칼슘·나트륨 등 전해질 이상, 요독증
- 마약성 진통제를 최근 늘렸거나 시작했는지
- 뇌전이·두개내압 상승(아침 두통, 신경 증상)
- 감염·약 때문에 생긴 위염·담도계 질환

구토가 있으면 의사는 항암제 외의 원인도 함께 살핍니다. 탈수가 있으면 생리식염수 수액을 맞고 이어서 큰 병원으로 안내받을 수 있습니다.

질의응답 — 메토클로프라미드(맥페란)

구토에 쓰는 메토클로프라미드는 법원 판결 이후 적응증이 삭제되었다는 질문에, 연자는 **여전히 항암제 구역·구토에 사용하고 있다**고 답했습니다. 허가사항을 다시 확인한 내용으로 성인은 항암화학요법 후 지연된 구역·구토 예방, 방사선요법 유발 구역·구토 예방, 구역·구토의 증상 치료가 기재되어 있고, 1~18세 소아는 2차 치료로서 항암화학요법 후 지연된 구역·구토 예방이 기재되어 있다고 했습니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

아산 28회 연수강좌 — 암 환자가 우리 병원에 왔을 때: 개원의를 위한 증상 관리 가이드(정재호)

본 자료는 항암 치료 중 구역·구토 관리를 위한 일반 안내입니다. 약의 종류·용량·기간은 처방전과 담당 의료진의 안내를 따르시고, 궁금한 점은 진료 때 물어보세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/oncology/asl28-olanzapine-chemo-nausea/